جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : ناهد عبدالفتاح عبدالحميد محمد
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اوسيم **العنوان :** -5ش الجيش
رقم البطاقة : 29103232101841 **رقم التليفون :** 01019671085 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 23-03-1991**المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ناهد عبدالفتاح عبدالحميد محمد
National ID: 29103232101841

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Dms
مصطفى
تعاليل وفحوصات



National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

05/09/2026

MDT FORM

Name:		HRN:	12219
Age:	35 Y	ID:	29103232101841
Menopausal Sta		Phone:	01019971005
NRS SCORE:		Marital Status:	Married
BMI:		Family History:	-ve
CO Morbidity:	NAD	Reason Of MDT:	new

Clinical Data:

DX: IDC G 1

ER: 7/8 PR: 7/8 HER2: 1 KI67: 40%

Sonomammography:
CESM:Lt upq and retroareolar 9x7.6x8.5 cm mass and non mass enhancement
Bilateral pathological axillary LN

Mets Workup:
PASE

History:

Recommendations:
By examination T3 N1 For possibility of NACT

MDT Outcome & Plan
FOR BRACKETING OF THE LESION TO STUDY NACT AC *4 TX" *4 + ZOLADEX
AS OVARIAN PRESERVATION THEN FOR CENTRAL QUADRANTECTOMY vs
MASTECTOMY ACCORDING TO RESPONSE

R L

TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatrie

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :10-6-2026

جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) ناهد عبدالفتاح عبدالحميد بطاقة رقم 29103232101841

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :10-6-2026

الموظف المختص
كريمة ابراهيم

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 1993810

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-HIO Letter
[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

GUSTAVE ROUSSY
Gustave Roussy International Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي الترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	ولاء عبدالمنعم حسين	**Case No.**	**328599**
Sex/Age	**Female 48 Y**	**Patient No.**	**24147**
Registered Date	**25/6/2026 03:08:01 PM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**20/7/2026 01:46:32 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**29/7/2026 11:30:00 AM**	**Pathology No.**	**SR-751/26**

Breast Slide Revision

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Referred blocks & slides (Wide local excision & axillary lymph nodes dissection).

Gross Examination:
- Eight referred blocks labelled by (AG 82/26). Together with, nine referred (H&E) stained slides.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade: 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 1).
* Ductal carcinoma in situ: Absent.
* Angioinvasion: Present.
* Perineural invasion: Absent.
* Microcalcification: Absent.
* Surgical margins: Free.
* Axillary lymph nodes: Positive metastatic deposits in twenty-four out of twenty-six lymph nodes (24/26) with extra-nodal extension.
** Slide labelled as (Frozen AG82): Imprint slide, Positive for malignant cells.

غرفة رقم (4) – الدور الاول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة 2 – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

GUSTAVE/ ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي الترانشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	ولاء عبدالمنعم حسين	**Case No.**	**328599**
Sex/Age	**Female 48 Y**	**Patient No.**	**24147**
Registered Date	**25/6/2026 03:08:01 PM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**20/7/2026 01:46:32 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**29/7/2026 11:30:00 AM**	**Pathology No.**	**SR-751/26**

IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 5% of tumor cells (score 5/8)
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 20%.

Diagnosis:
Left breast mass, Referred blocks & slides (Wide local excision & axillary lymph nodes dissection):
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- Ductal carcinoma in situ: Absent.
- Surgical margins: Free.
- Axillary lymph nodes: Positive metastatic deposits in twenty-four out of twenty-six lymph nodes (24/26) with extra-nodal extension.

IPT:
- ER: Positive (8/8).
- PR: Positive (5/8).
- Her2: Low (Score 1+).
- Ki67%: 20%.

* ***Scoring system: "ER, PR"**
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* ****Scoring system: "Her2"**
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

GUSTAVE ROUSSY
Gustave Roussy International-Egypt: Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	ولاء عبدالمنعم حسين	**Case No.**	**328599**
Sex/Age	**Female 48 Y**	**Patient No.**	**24147**
Registered Date	**25/6/2026 03:08:01 PM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**20/7/2026 01:46:32 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**29/7/2026 11:30:00 AM**	**Pathology No.**	**SR-751/26**

staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Maha Guimei.
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Name : MRs. Walaa AbdelMonem Hassan

Date : - 15/04/26

High resolution breast US:

- Both breast parenchyma appear homogenously hyperechoic , no focal lesions could be detected .Normal duct caliber .

Left Axilla: Multiple globular enlarged axillary LN with thickened cortex. Some with Loss fat sinus and some with preserved fat sinus, largest one measuring 2.7 x 1.6 cm FNACS is done and proved with histpathology as metastatic adenocarcinoma .

OPINION:-

-Multiple left malignant axillary lymph nodes FNAC is done and proved by histopathology as metastatic carcinoma BIRAD 6.
-No breast mass lesion has been detected .
- Pet scan is recommended.

Dr. Zeinab Elnady

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

Name: Walaa Abdelmoinem Hassan Date: 21-4-2026
MRN : 30209575

F18-FDG PET/CT STUDY

CLINICAL HISTORY:

48 years old female patient with left axillary LNS

REASON FOR PET/CT STUDY:

- Initial assessment.

TECHNIQUE:

- **Radiopharmaceutical:** 18F FDG.
- **Blood glucose at time of 18F-FDG injection:** mg/dL.
- **Time from 18F-FDG injection to scan:**60 min
- **PET/CT images** were acquired from the skull base through the upper thighs & **CT images** were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- **Additional notes: SUV max normalized to body weight was used.**
- **IV contrast was administered.**

COMPARISON: No previous PET CT studies.

FINDINGS:

Head and Neck:

* No hypermetabolic cervical lymphadenopathy detected
* No FDG avid thyroid nodules.
* Physiologic FDG uptake is seen in the oropharynx, salivary glands, and larynx.
* Normal diffuse brain activity with NO hypermetabolic brain lesions.

Chest:

* **small FDG avid nodule is seen at the LOQ of the left breast measuring 1.5x1.4 cm with SUVmax~4.5, for sono-mammography assessment**
* **FDG avid left infra-clavicular LN seen measures 1.3x0.8 cm with SUVmax~4.7.**
* **Multiple FDG avid left sub-pectoral and axillary LNS are seen, the largest measures 2.9x1.7 cm with SUVmax~8.6.**
* There is no hypermetabolic mediastinal lymphadenopathy.
* NO FDG avid lung nodules or masses detected.
* No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.
* Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:

* bilateral adnexal lesions are seen, measure 3.9x2.3 cm at the right side and 3.5x2.4 cm at the left side
* There is no hypermetabolic abdominal or pelvic lymphadenopathy.
* The liver is enlarged and homogenous parenchymatous texture with NO FDG avid focal lesions detected.
* The spleen is of average size with NO FDG avid focal lesions detected. splenule is noted
* The pancreas shows normal FDG avidity.
* There are no active adrenal nodules.
* Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder
* bulky uterus is noted

Musculoskeletal:

* Normal FDG activity is seen over the axial skeleton. No focal active blastic or lytic bone lesions detected.

Seket Al-Emam st, El Sayda Zainab, Cairo
O. Box: 1 El Dawawin, Egypt
l: (202) 19057
x: (202) 25 35 1745
mail: info@57357.org
www.57357.org
رحلة علم هدفها الحياة
ا شارع سكة الإمام - السيدة زينب - القاهرة
ص . ب : ا الدواوين - مصر
الهاتف : (202) 19057
فاكس : (202) 25 35 1745
57357Egypt

IMPRESSION:

PET-CT study showing:

- Positive study for FDG avid left breast nodular lesion likely neoplastic associated with active metastatic nodal deposits for pathological verification.

Thanks for referral;

Nuclear Medicine Unit;

Dr. Rehab Hussein, MD
Radiology Consultant

Dr. Aya Ashraf, MD
Nuclear Medicine Consultant.

Seket Al-Emam st, El Sayda Zainab, Cairo
P.O. Box: 1 El Dawawin, Egypt
Tel: (202) 19057
Fax: (202) 25 35 1745
E-mail: info@57357.org

www.57357.org
رحلة علم صدفها الحياة

١ شارع سكة الإمام - السيدة زينب - القاهرة
ص . ب : ١ الدواوين - مصر
الهاتف : 19057 (202)
فاكس : 1745 35 25 (202)
57357Egypt

Egypt Cancer Network USA
Egypt Cancer Network Canada
Egypt Cancer Network
PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

حملة سرطان الثدي للمبادرة الرئاسية مليون صحة

رقم الحالة: 96/26
التاريخ: 16/3/2026
الاسم: ولاء عبدالمنعم حسن محمد
الرقم القومي: 27801101402902

السن: 54 -

GROSS PICTURE:
Received single tissue core measured 0. 7 cm in length with some tissue fragments collectively measured 0.3x0.3cm, greyish white. Totally submitted.

MICROSCOPIC PICTURE:

Sections examined from totally submitted specimen revealed lymphnode with parenchyma with effacement of normal architecture showing infiltration by malignant neoplastic growth deposited in sheets and ducts of malignant epithelial cells. The cells were pleomorphic, showing increased N/C ratio, hyperchromatic nuclei with prominent nucleoli. The overall anaplasia was moderate

Diagnosis:
U/S-Guided Tru-Cut Biopsy –left axillary pathological lymph nodes:

-Metastatic adenocarcinoma for further work up.

Please Correlate With Clinical And Radiological Data.

REVIEWED BY: DR. Hadeer Maher.

VERIFIED BY: Ass. Prof. Dr. Eman Saeed.
VERIFIED BY: Prof. Dr. Omnia Youssef.

VERIFIED BY: Prof. Dr. Ghada Ahmed.

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: ناهد عبدالفتاح عبد الحميد
Request type: مبادره
Hospital no:
Department: صحه مراه
Referred by: د/هدايه نور
Nature of specimen: tru-cut biopsy
Clinical diagnosis: Left breast mass

Age: 35years **Sex:** female
Sub request type:
Pathology no.:493B-2026
Date of result:23/6/2026
Date of biopsy:14/6/2026
I.D. Number:29103232101841

Gross pathology :
Multiple gray white tissue cores measured 1cm, totally submitted

Immunohistochemical Technique: Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against:ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture:
Section examined revealed breast core tissue showed clusters, nests, cribriform pattern of anaplastic ductal cells with moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules dispersed among desmoplastic stroma with mild lymphocytic response. Also seen ductal carcinoma insitu of intermediate grade, solid subtype.

Immunohistochemical Result:
ER: Moderate nuclear staining in 80% of tumor cells (Allred Score 7/8).
PR: Moderate nuclear staining of 70% of tumor cells (Allred Score 7/8).
Her2: Faint incomplete membranous staining of >10%tumor cells (score 1+)
Ki67: Positive nuclear staining of 40% of tumor cells.

Diagnosis: Left breast mass: Tru Cut Biopsy:
Invasive Duct Carcinoma (NST), Grade II

Signature:
Dr.Nermine Nabil.M.D

1/7/2026

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient ID: 265555255	Patient Name English: Nahad abdalftah
:Age	2026/06/08 10:41:34 AM :Report Date

2

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary:3 5 years old female patient with left breast lump.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The Left breast shows UOQ area of asymmetry and distortion with speculated outline about 45mm in longest diameter .
- Ipsilateral enlarged lymph node
- **Ultrasound** revealed a 42x29mm sized ill-defined hypoechoic area of architectural distortion mounting to non mass lesion located from 1-3 o'clock and also occupying the retroareolar region
- Normal nipple/areolar complex.
- A solitary enlarged level I pathological lymph node measures 10x6mm with cortical thickness of 5mm .

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 4c): Left U0Q suspicious non mass lesion described. Tru cut biopsy is advisable**
- **Right breast (BIRADS 1): normal study.**

Much obliged,
Dr. Marwa a. el seoud

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]